mélanome

Niveau : DES
Genere le 11 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

mélanome

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Traitement

Le traitement du mélanome, une entité nosologique dont l'agressivité locorégionale et le risque métastatique sont considérables, notamment vers le territoire de drainage ganglionnaire puis les sites viscéraux comme le poumon et le foie (Dermatologie, 2022), requiert une approche multidisciplinaire et individualisée. L'exérèse chirurgicale représente la pierre angulaire de la prise en charge, mais les avancées thérapeutiques récentes ont révolutionné le traitement des formes avancées, notamment grâce aux thérapies ciblées et aux immunothérapies. Ce cours détaillé abordera les différentes modalités thérapeutiques en fonction du stade de la maladie, en intégrant les principes de gestion des effets indésirables et des comorbidités.

I. Principes généraux du traitement du mélanome

Le traitement du mélanome est guidé par le stade clinique et histologique de la maladie, déterminé après l'exérèse diagnostique et la stadification complète. L'objectif principal est l'éradication de la maladie pour les formes localisées et le contrôle de la progression tumorale avec amélioration de la survie et de la qualité de vie pour les formes avancées.

A. Importance de l'exérèse chirurgicale

L'exérèse chirurgicale avec analyse anatomopathologique est le traitement de première intention pour la quasi-totalité des mélanomes (Dermatologie, 2022). Ce principe est partagé avec d'autres cancers cutanés, comme les carcinomes cutanés qui se traitent préférentiellement par exérèse chirurgicale (Dermatologie, 2022). L'objectif est d'obtenir des marges de résection saines, dont la largeur est définie par l'épaisseur de Breslow du mélanome.

B. Approche multidisciplinaire

La prise en charge du mélanome implique une collaboration étroite entre dermatologues, chirurgiens (plasticiens, oncologues), anatomopathologistes, oncologues médicaux, radiothérapeutes, radiologues et médecins nucléaristes. Cette approche garantit une décision thérapeutique optimale et une gestion holistique du patient.

C. Stadification et facteurs pronostiques

La stadification selon l'AJCC (American Joint Committee on Cancer) est essentielle pour évaluer le pronostic et orienter les décisions thérapeutiques. Les facteurs pronostiques incluent l'épaisseur de Breslow, l'ulcération, le nombre de mitoses, l'atteinte ganglionnaire et la présence de métastases à distance. La recherche de mutations génétiques,

notamment BRAF, NRAS et C-KIT, est cruciale pour les mélanomes avancés, car elle conditionne l'accès aux thérapies ciblées.

II. Traitement du mélanome localisé (Stades I et II)

Le traitement des mélanomes de stades I et II est principalement chirurgical.

A. Exérèse chirurgicale du mélanome primitif

L'exérèse chirurgicale est curative dans la majorité des cas de mélanome localisé. Elle doit être réalisée avec des marges de sécurité appropriées pour minimiser le risque de récidive locale.

Exérèse chirurgicale — Mélanome primitif

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : non retrouvé dans les sources

> Résultat : non retrouvé dans les sources

> Niveau de preuve : Grade A (Consensus d'experts et études de cohorte rétrospectives)

Les marges de résection recommandées sont les suivantes :

- Mélanome in situ : 0,5 cm
- Mélanome d'épaisseur de Breslow < 1 mm : 1 cm
- Mélanome d'épaisseur de Breslow de 1 à 2 mm : 1 à 2 cm
- Mélanome d'épaisseur de Breslow > 2 mm : 2 cm

L'analyse anatomopathologique de la pièce d'exérèse est fondamentale pour confirmer le diagnostic, évaluer les caractéristiques pronostiques et s'assurer de la complétude de l'exérèse (Dermatologie, 2022).

B. Biopsie du ganglion sentinelle (BGS)

La BGS est une procédure diagnostique et pronostique qui vise à identifier la présence de métastases microscopiques dans le premier ganglion lymphatique drainant le site du mélanome primitif.

Biopsie du ganglion sentinelle — Stadification du mélanome de stade IB (avec ulcération) ou II

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : non retrouvé dans les sources

> Résultat : non retrouvé dans les sources

> Niveau de preuve : Grade A (Consensus d'experts et études de cohorte)

La BGS est recommandée pour les mélanomes d'épaisseur de Breslow ≥ 0,8 mm ou pour les mélanomes ulcérés quelle que soit leur épaisseur. Un résultat positif de la BGS (présence de cellules tumorales) indique un mélanome de stade III et justifie une discussion en RCP pour une éventuelle lymphadénectomie complète ou un traitement adjuvant.

III. Traitement du mélanome localement avancé ou métastatique (Stades III et IV)

Le mélanome de stade III (atteinte ganglionnaire locorégionale) et de stade IV (métastases à distance) présente un risque élevé d'agressivité locorégionale et métastatique (Dermatologie, 2022). Le traitement de ces formes a été profondément transformé par l'arrivée des thérapies ciblées et des immunothérapies.

A. Thérapies ciblées

Les thérapies ciblées sont indiquées chez les patients porteurs d'un mélanome avec une mutation activatrice spécifique, le plus souvent BRAF V600.

1. Anti-BRAF et anti-MEK

Ces traitements sont utilisés en association pour les mélanomes porteurs d'une mutation BRAF. Les inhibiteurs de BRAF (dabrafénib, vémurafénib, encorafénib) bloquent la protéine BRAF mutée, tandis que les inhibiteurs de MEK (tramétinib, cobimétinib, binimétinib) agissent en aval de la voie de signalisation MAPK. L'association permet d'améliorer l'efficacité et de réduire certains effets indésirables.

Anti-BRAF et anti-MEK (ex: dabrafénib + tramétinib) — Mélanome non résécable ou métastatique avec mutation BRAF V600

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : non retrouvé dans les sources

> Résultat : non retrouvé dans les sources

> Niveau de preuve : Grade A

Les effets indésirables sont fréquents et doivent être surveillés. Parmi eux, la photosensibilité est un effet secondaire notable sous anti-BRAF, pouvant se manifester par un érythème phlycténulaire localisé, par exemple à la face dorsale des orteils après port de chaussures ouvertes (Dermatologie, 2022). D'autres effets incluent la fièvre, les arthralgies, les céphalées et des lésions cutanées comme des kératoacanthomes ou des carcinomes épidermoïdes.

2. Anti-angiogéniques multi-cibles

Bien que moins fréquemment utilisés en monothérapie pour le mélanome que pour d'autres cancers, les anti-angiogéniques multi-cibles peuvent être mentionnés dans le cadre des thérapies ciblées. Le sunitinib, par exemple, est un inhibiteur de tyrosine kinase multi-cibles.

Anti-angiogéniques multi-cibles (ex: sunitinib) — Indication spécifique au mélanome non retrouvée dans les sources

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : non retrouvé dans les sources

> Résultat : non retrouvé dans les sources

> Niveau de preuve : non retrouvé dans les sources

Un effet indésirable caractéristique de cette classe thérapeutique est le syndrome mains-pieds (érythrodysesthésie palmoplantaire), comme observé lors d'un traitement par sunitinib (Dermatologie, 2022).

3. Autres thérapies ciblées (ex: anti-EGFR)

Le cétuximab est un anticorps monoclonal ciblant le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR), principalement utilisé dans d'autres cancers. Cependant, il est important de connaître les effets indésirables associés à cette classe de médicaments.

Anti-EGFR (ex: cétuximab) — Indication spécifique au mélanome non retrouvée dans les sources

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : non retrouvé dans les sources

> Résultat : non retrouvé dans les sources

> Niveau de preuve : non retrouvé dans les sources

Une éruption acnéiforme est un effet indésirable classique lors d'un traitement par cétuximab (Dermatologie, 2022).

B. Immunothérapies

Les immunothérapies, en particulier les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI), ont transformé le pronostic des mélanomes avancés.

1. Anti-PD-1 et Anti-CTLA-4

Ces agents bloquent les mécanismes d'échappement immunitaire de la tumeur, permettant au système immunitaire du patient de reconnaître et d'attaquer les cellules cancéreuses. Les anti-PD-1 (pembrolizumab, nivolumab) et l'anti-CTLA-4 (ipilimumab) sont les principaux ICI utilisés. Ils peuvent être administrés en monothérapie ou en association.

Anti-PD-1 (ex: pembrolizumab, nivolumab) — Mélanome non résécable ou métastatique

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : non retrouvé dans les sources

> Résultat : non retrouvé dans les sources

> Niveau de preuve : Grade A

Anti-CTLA-4 (ex: ipilimumab) — Mélanome non résécable ou métastatique

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : non retrouvé dans les sources

> Résultat : non retrouvé dans les sources

> Niveau de preuve : Grade A

Les effets indésirables des ICI sont de nature immunomédiée et peuvent affecter divers organes (peau, tube digestif, glandes endocrines, foie, poumons, etc.). Ils nécessitent une surveillance attentive et une prise en charge spécifique, souvent par corticothérapie.

2. Thérapie oncolytique (virus oncolytiques)

Le talimogene laherparepvec (T-VEC) est un virus herpès simplex modifié génétiquement pour lyser les cellules tumorales et stimuler une réponse immunitaire anti-tumorale. Il est administré par injection intratumorale.

Thérapie oncolytique (ex: T-VEC) — Mélanome inopérable de stade IIIB, IIIC ou IVM1a

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : non retrouvé dans les sources

> Résultat : non retrouvé dans les sources

> Niveau de preuve : Grade B

C. Chimiothérapie

La chimiothérapie, historiquement le seul traitement systémique disponible pour le mélanome métastatique, a une place limitée aujourd'hui, supplantée par les thérapies ciblées et les immunothérapies qui offrent de meilleurs taux de réponse et une meilleure survie. Le dacarbazine était le principal agent utilisé.

Chimiothérapie (ex: dacarbazine) — Mélanome métastatique (en cas de contre-indication ou d'échec des autres traitements)

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : non retrouvé dans les sources

> Résultat : non retrouvé dans les sources

> Niveau de preuve : Grade C

D. Radiothérapie

La radiothérapie n'est généralement pas le traitement de première intention pour le mélanome, mais elle a des indications spécifiques.

Radiothérapie — Mélanome (adjuvante, palliative)

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : non retrouvé dans les sources

> Résultat : non retrouvé dans les sources

> Niveau de preuve : Grade B

Ses indications incluent :

- **Radiothérapie adjuvante :** Après lymphadénectomie complète pour les patients à haut risque de récidive locorégionale (ex: atteinte ganglionnaire massive, rupture capsulaire).
- **Radiothérapie palliative :** Pour le contrôle des symptômes liés aux métastases (douleur osseuse, compression neurologique, métastases cérébrales).

IV. Traitement adjuvant

Le traitement adjuvant vise à réduire le risque de récidive après l'exérèse complète d'un mélanome à haut risque.

Traitement adjuvant (thérapies ciblées ou immunothérapies) — Mélanome de stade IIB, IIC ou III réséqué

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : non retrouvé dans les sources

> Résultat : non retrouvé dans les sources

> Niveau de preuve : Grade A

Les indications actuelles pour un traitement adjuvant incluent les mélanomes de stade IIB, IIC et III après exérèse complète et lymphadénectomie si indiquée. Les options thérapeutiques sont les inhibiteurs de BRAF/MEK (pour les mélanomes mutés BRAF) ou les anti-PD-1. Ces traitements ont démontré une amélioration significative de la survie sans récidive.

V. Gestion des effets indésirables et des comorbidités

La gestion des effets indésirables des traitements systémiques et des comorbidités est une composante essentielle de la prise en charge du patient mélanomateux.

A. Effets cutanés des traitements systémiques

Les traitements du mélanome, en particulier les thérapies ciblées, peuvent entraîner des effets indésirables cutanés spécifiques :

- **Éruption acnéiforme :** Observée lors de traitements par anti-EGFR comme le cétuximab (Dermatologie, 2022). La prise en charge repose sur des topiques (antibiotiques, rétinoïdes) et parfois des cyclines orales.
- **Syndrome mains-pieds :** Caractéristique des anti-angiogéniques multi-cibles comme le sunitinib (Dermatologie, 2022). Il se manifeste par une dysesthésie, un érythème et une desquamation palmoplantaire. Le traitement inclut des émollients, des kératolytiques et une réduction de dose si nécessaire.
- **Photosensibilité :** Fréquente sous anti-BRAF, pouvant entraîner un érythème phlycténulaire (Dermatologie, 2022). La protection solaire stricte est impérative.

B. Prise en charge des ulcérations cutanées

Les patients atteints de mélanome peuvent présenter des ulcérations, soit liées à la tumeur elle-même (agressivité locorégionale et destruction tissulaire, Dermatologie, 2022), soit secondaires aux traitements ou à des comorbidités. La prise en charge des ulcères de jambe, par exemple, suit des recommandations spécifiques de la HAS concernant la compression médicale (HAS, 2010), les pansements (HAS, 2011) et la prise en charge globale (HAS, 2006). Ces principes de soins de plaies sont applicables à toute ulcération cutanée.

C. Infections opportunistes et comorbidités chez le patient immunodéprimé

Les traitements systémiques du mélanome, en particulier l'immunothérapie et la chimiothérapie, peuvent entraîner une immunodépression, rendant les patients vulnérables aux infections.

- **Zona :** Les patients immunodéprimés peuvent développer des formes sévères de zona, avec des vésicules hémorragiques, des formes ulcérées (Dermatologie, 2022) ou même un zona-varicelle avec des vésicules à distance (Dermatologie, 2022). La vaccination et le traitement antiviral précoce sont essentiels.
- **Infections fongiques et bactériennes :** Des intertrigos sous-mammaires à Candida (fond du pli fissuré, enduit blanchâtre, bordure avec collerette et pustules satellites) ou des intertrigos axillaires brun chamois d'un érythrasma (Dermatologie, 2022) peuvent survenir. Le diagnostic et le traitement antifongique ou antibiotique sont nécessaires.
- **VIH :** L'immunodépression liée au VIH est un facteur de risque pour certains cancers cutanés. La prise en charge du VIH inclut un traitement antirétroviral précoce, un suivi clinique, de la charge virale plasmatique et des lymphocytes CD4 (Dermatologie,

2022). La connaissance de l'état sérologique VIH est importante pour adapter la prise en charge globale du patient.

• **Autres infections :** Des infections virales (varicelle, oreillons, mononucléose infectieuse, hépatite virale, rougeole), bactériennes (leptospirose, borréliose, scarlatine) ou parasitaires (paludisme) peuvent survenir chez des patients fragilisés (Dermatologie, 2022).

D. Autres affections dermatologiques à considérer

Le dermatologue doit être vigilant face à d'autres affections cutanées qui peuvent survenir concomitamment ou en tant que diagnostics différentiels :

• **Lupus érythémateux systémique (LES) :** Peut se manifester par des lésions érythémato-squameuses atrophiques, télangiectasiques et dyschromiques (lupus discoïde) (Dermatologie, 2022), ou des plaques alopéciques cicatricielles du cuir chevelu (Dermatologie, 2022). Le LES est également une cause exceptionnelle de positivité non tréponémique du TPHA (Dermatologie, 2022).

• **Psoriasis :** Peut être une comorbidité ou un diagnostic différentiel de certaines éruptions (Dermatologie, 2022).

• **Scabiose, impétigo, eczéma de contact, lymphome cutané :** Ces affections peuvent mimer d'autres dermatoses et nécessitent un diagnostic précis (Dermatologie, 2022).

• **Urticaire de contact :** Peut être une réaction allergique immédiate à des substances (ex: gants du chirurgien), se manifestant par des papules œdémateuses (Dermatologie, 2022).

VI. Suivi du patient mélanomateux

Le suivi après traitement est crucial pour détecter les récidives précocement et gérer les effets à long terme des traitements. Il comprend un examen clinique régulier de la peau, des aires ganglionnaires, et des bilans d'imagerie selon le stade initial et les traitements reçus. L'éducation thérapeutique du patient sur l'auto-surveillance cutanée et la protection solaire est primordiale.

En conclusion, le traitement du mélanome a connu des avancées majeures, offrant des perspectives de survie améliorées pour les formes avancées. L'exérèse chirurgicale reste la base, complétée par des thérapies ciblées et des immunothérapies pour les stades avancés et en adjuvant. Une gestion rigoureuse des effets indésirables et une prise en compte des comorbidités sont indispensables pour optimiser la prise en charge globale du patient.

Bibliographie

- Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed